検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KC3A
検索者名	-	検索者コード	KD55
レコード種別	161		
テーマコード	2G045		
特許出願の番号	特願2023-557063		
外注管理番号	2025098507		
納品種別	03U0C00100		
対話実施日	2026年 1月21日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 1月14日		
検索報告書作成日	2026年 1月14日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：6-1,2　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

メラノーマ患者に対するスパルタリズマブ-ダブラフェニブ-トラメチニブ治療において、高レベルのＣＤ４＋／ＣＤ８＋またはｃｔＤＮＡの患者の生存率が高い

【構成要素】

1a：癌治療に対する応答の特定方法(F6-1,2)

1b：ＣＤ８＋／ＣＤ４＋を取得(F6-1,2)

1c：癌免疫療法と標的療法との組み合わせのとき、大きいＣＤ８＋／ＣＤ４＋が高利益、または、標的療法のみのとき、小さいＣＤ８＋／ＣＤ４＋が高利益(F6-1,2)

2a：癌免疫療法と標的療法との組み合わせのとき、小さいＣＤ８＋／ＣＤ４＋が低利益(F6-1,2)

3a：請求項２の治療選択方法

4a：治療のために対象を選択(F6-1,2)

5a：請求項１の医薬組成物

6a：ＣＤ８＋／ＣＤ４＋が細胞量比(F6-1,2)

7a：ＣＤ８＋／ＣＤ４＋が２など(F6-3)

8a：ＣＤ８＋／ＣＤ４＋が細胞レベルを決定(F6-1,2)

9a：試料が血液など(F6-1,2)

10a：ＣＤ８＋／ＣＤ４＋が細胞治療１か月後などに取得(F6-1,2)

11a：ＴＩＬの増加が高利益(F15-6)

12a：ＴＭＢの増加が高利益(F7-1)

13a：ＴＭＢが１０ｍｕｔ／Ｍｂ以下(F7-1)

14a：ＰＤ-Ｌ１の減少が高利益(F7-1)

15a：ｃｔＤＮＡの増加が高利益(F19-3-6)

16a：対象のＰＦＳなどが改善(F6-1,2)

17a：ＰＦＳなどが１か月など改善(F6-1,2)

18a：対象が治療されている(F6-1,2)

19a：標的治療がダブラフェニブとトラメチニブ(F6-1,2)

20a：癌免疫療法がＰＤ-１アンタゴニスト(F6-1,2)

21a：癌免疫療法が抗ＰＤ-１抗体(F6-1,2)

22a：癌が黒色腫など(F6-1,2)

23a：さらなる治療(F6-1,2)

24a：治療がファーストラインなど(F6-1,2)

25a：ＴＩＬなどを取得(F6-1,2)

26a：請求項３の対象層別化方法

【請求項1-2】

1a：治療から利益を得る可能性が高いがんを有する対象を特定する方法であって、

1b：前記対象からの試料中のＣＤ８＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性に対するＣＤ４＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性の値を取得するステップを含み、かつ、

1c：（ａ）参照値よりも大きいかまたはそれに等しい値が、前記対象を、前記治療からの利益を得る可能性が高いことを特定し、前記治療が、がん免疫療法と組み合わせて標的治療を含むか、または　（ｂ）参照値よりも小さい値が、前記対象を、前記治療からの利益を得る可能性が高いことを特定し、前記治療が、がん免疫療法を用いない標的治療を含む、方法。

2a：（ａ）参照値よりも大きいかまたはそれに等しい値を有すると特定された前記対象が、がん免疫療法を用いない標的治療を含む治療と比較して、がん免疫療法と組み合わせた前記標的治療を含む前記治療からの利益の増加を有する可能性が高いか、または　（ｂ）参照値よりも小さい値を有すると特定された前記対象が、がん免疫療法と組み合わせて前記標的治療を含む治療からの利益の実質的な増加を有する可能性が低い、請求項１に記載の方法。

【請求項3-4】

3a：治療をがんを有する対象のために選択する方法であって、　前記対象からの試料中のＣＤ８＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性に対するＣＤ４＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性の値を取得するステップ、および　（ａ）前記値が、参照値よりも大きいかまたはそれに等しい場合、がん免疫療法と組み合わせて標的治療を含む治療を前記対象のために選択するステップ、または　（ｂ）前記値が、参照値よりも小さい場合、がん免疫療法を用いない標的治療を含む治療を前記対象のために選択するステップを含む方法。

4a：前記対象が、　（ａ）前記治療の有効量の初回投与または継続投与、　（ｂ）前記治療の変更された投与レジメンの投与、　（ｃ）異なる治療の投与の中断、　（ｄ）追加の治療の投与、または　（ｅ）前処置の投与であって、前記前処置が、前記対象からの試料中のＣＤ８＋免疫エフェクター細胞の前記レベルまたは活性に対するＣＤ４＋免疫エフェクター細胞前記レベルまたは活性の前記値を増加させる、前処置の投与、のために選択される、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。

【請求項5-25】

5a：がんを有する対象を処置する方法を含む治療において使用するための、標的治療剤を含む医薬組成物であって、前記方法が、　前記対象からの試料中のＣＤ８＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性に対するＣＤ４＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性の値を受けて、　（ａ）がん免疫療法と組み合わせて前記医薬組成物の有効量を、参照値よりも大きいかまたはそれに等しい値を有する前記対象に投与するステップ、または　（ｂ）がん免疫療法を用いない前記医薬組成物を、参照値よりも小さい値を有する対象に投与するステップを含む方法。

6a：ＣＤ８＋免疫エフェクター細胞の前記レベルまたは活性に対するＣＤ４＋免疫エフェクター細胞の前記レベルまたは活性の前記値が、ＣＤ８＋免疫エフェクター細胞の量に対するＣＤ４＋免疫エフェクター細胞の量の比を含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法、または請求項５に記載の医薬組成物。

7a：前記値が、　（ａ）以下より大きいかもしくはそれに等しい：　（ｉ）２、　（ｉｉ）２．５、３、３．５、４、４．５、５、５．５、６、６．５、７、７．５、８、８．５、９、９．５、もしくは１０、　（ｉｉｉ）３．３、もしくは　（ｉｖ）３．５、４、４．５、５、５．５、６、６．５、７、７．５、８、８．５、９、９．５、もしくは１０、または　（ｂ）以下より小さい：　（ｉ）３．３、　（ｉｉ）３、２．５、２、１．５、１、もしくは０．５　（ｉｉｉ）２、もしくは　（ｉｖ）１．５、１、もしくは０．５請求項６に記載の方法、または医薬組成物。

8a：前記値を取得するステップが、前記対象からの試料中のＣＤ８＋免疫エフェクター細胞の前記レベルまたは活性に対するＣＤ４＋免疫エフェクター細胞の前記レベルまたは活性を決定することを含む、請求項１から４、６、または７のいずれか一項に記載の方法。

9a：（ａ）前記対象からの前記試料が、血液試料または腫瘍試料を含む、　（ｂ）前記値が、前記治療の投与が開始される前に取得される、および／または　（ｃ）前記値が、前記治療の投与が開始された後に取得される、請求項１から４、または６から８のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７のいずれか一項に記載の医薬組成物。

10a：前記値が、前記治療の投与が開始された１、２、３、４、８、１０、１２、２０、３０、４０週間後もしくはそれ以降または１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１２、１４、１６、１８、２０カ月後もしくはそれ以降に取得される、請求項９に記載の方法、または医薬組成物。

11a：前記方法が、前記対象からの試料中のＣＤ８＋腫瘍浸潤リンパ球（ＴＩＬ）のレベルまたは活性の値を取得するステップをさらに含み、参照値と比較した場合のＣＤ８＋ＴＩＬのレベルまたは活性の値の増加が、前記対象ががん免疫療法と組み合わせた前記標的治療を含む治療からの利益を得る可能性が高いことをさらに特定する、請求項１から４または６から１０のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７、９、または１０のいずれか一項に記載の医薬組成物。

12a：前記方法が、前記対象からの試料中の腫瘍遺伝子変異量（ＴＭＢ）の値を取得するステップをさらに含み、　（ａ）参照値と比較した場合のＴＭＢの値の増加が、前記対象が、がん免疫療法と組み合わせた標的治療を含む前記治療からの利益を得る可能性が高いことをさらに特定する、　（ｂ）参照値と比較した場合のＴＭＢの値の減少が、前記対象が、がん免疫療法を用いない前記治療からの利益を得る可能性が高いことをさらに特定する、または　（ｃ）参照値と比較した場合のＴＭＢの値の減少が、前記対象が、がん免疫療法と組み合わせた標的治療を含む治療からの利益の実質的な増加を有する可能性が低いことをさらに特定する、請求項１から４または６から１１のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７、または請求項９から１１のいずれか一項に記載の医薬組成物。

13a：ＴＭＢの前記値が、　（ａ）１０ｍｕｔ／Ｍｂよりも大きいかもしくはそれに等しい、または　（ｂ）１０ｍｕｔ／Ｍｂ未満、例えば、９、８、７、６、５、４、３、２、もしくは１ｍｕｔ／Ｍｂ未満、またはそれよりも小さい、請求項１２に記載の方法、または医薬組成物。

14a：前記方法が、前記対象からの試料中のＰＤ-Ｌ１のレベルおよび／または活性の値を取得するステップをさらに含み、　（ａ）参照値と比較した場合のＰＤ-Ｌ１の前記レベルおよび／または活性の値の減少が、前記対象が、がん免疫療法と組み合わせた標的治療を含む前記治療からの利益を得る可能性が高いことをさらに特定する、　（ｂ）ＰＤ-Ｌ１のレベルおよび／または活性の値の減少が、例えば、ＴＭＢの値の減少と共に、前記対象ががん免疫療法を用いない前記治療からの利益を得る可能性が高いことをさらに特定する、　（ｃ）ＰＤ-Ｌ１のレベルおよび／または活性の値の減少が、ＴＭＢの値の減少と共に、前記対象が、がん免疫療法と組み合わせて標的治療を含む治療からの利益の実質的な増加を有する可能性が低いことをさらに特定する、請求項１から４または６から１３のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７、または請求項９から１３のいずれか一項に記載の医薬組成物。

15a：前記方法が、前記対象からの試料中の循環腫瘍ＤＮＡ（ｃｔＤＮＡ）の値を取得するステップをさらに含み、参照値と比較した場合のｃｔＤＮＡの値の増加が、前記対象が前記治療からの利益を得る可能性が高いことをさらに特定する、請求項１から４または６から１４のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７、または請求項９から１４のいずれか一項に記載の医薬組成物。

16a：前記治療から利益を得る可能性の高い対象、または前記治療からの利益の増加を有する可能性の高い対象が、　（ａ）前記治療から利益を得る可能性の低い対象、または前記治療からの利益の増加を有する可能性の低い対象と比較して、無増悪生存期間（ＰＦＳ）、客観的奏効期間（ＤＯＲ）、および／または全生存期間（ＯＳ）の改善を有するか、または　（ｂ）前記治療を受けなかった対象、または標的治療だけを受けたがん免疫療法を受けなかった対象と比較して、ＰＦＳ、ＤＯＲ、および／またはＯＳの改善を有する、請求項１から４または６か

ら１５のいずれか一項に記載の方法。

17a：（ａ）前記ＰＦＳ、ＤＯＲ、および／またはＯＳが、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１８、２４、３０、３６、４２、４８、５４、６０カ月まで、またはそれより長く改善される、または　（ｂ）前記ＰＦＳ、ＤＯＲ、および／またはＯＳが、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、もしくは９０％、または１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０倍、またはそれより大きく改善される、請求項１６に記載の方法。

18a：（ａ）前記対象が、標的治療で処置されたか、または処置されている、　（ｂ）前記対象が、標的治療で処置されなかったか、または処置されていない、　（ｃ）前記対象が、がん免疫療法を受けたか、または受けている、　（ｄ）前記対象が、がん免疫療法を受けなかったか、または受けていない、　（ｅ）前記対象が、がん免疫療法と組み合わせて標的治療を含む治療を受けたか、　（ｆ）前記対象が、がん免疫療法と組み合わせて標的治療を含む治療を受けなかったか、または受けていない、　（ｇ）前記対象が、標的治療を受けたか、または受けており、がんが再発した、　（ｈ）前記対象が、標的治療に対するノンレスポンダーであるか、または標的治療に対するノンレスポンダーとして特定されている、または　（ｉ）前記対象が、標的治療に対するパーシャルレスポンダーであるか、または標的治療に対するパーシャルレスポンダーとして特定されている、請求項１から４または６から１７のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７、または請求項９から１５のいずれか一項に記載の医薬組成物。

19a：前記標的治療が、ＢＲＡＦを標的とする薬剤および／またはＭＥＫを標的とする薬剤を含み、　（ａ）ＢＲＡＦを標的とする前記薬剤が、野生型ＢＲＡＦおよび／またはＶ６００変異を有するＢＲＡＦを阻害する、　（ｂ）ＢＲＡＦを標的とする前記薬剤が、ダブラフェニブ、ベムラフェニブ、エンコラフェニブ、ＡＢＭ-１３１０、ＡＲＱ　７３６、ＡＳＮ００３、ＢＧＢ-２８３、ＢＧＢ-３２４５、ＣＥＰ-３２４９６、ＧＤＣ-０８７９、ＬＵＴ０１４、ＰＬＸ４７２０、ＰＬＸ８３９４、ＲＯ５２１２０５４、またはその薬学的に許容される塩である、　（ｃ）ＢＲＡＦを標的とする前記薬剤が、２５ｍｇ～３００ｍｇの間の用量で投与される、　（ｄ）ＭＥＫを標的とする前記薬剤が、トラメチニブ、コビメチニブ、ビニメチニブ、ミルダメチニブ、プマセルチブ、レファメチニブ、セルメチニブ、ＡＳ７０３９８８、ＡＺＤ　８３３０、ＢＩ　８４７３２５、ＢＩＸ　０２１８８、ＢＩＸ　０２１８９、ＣＩ-１０４０、ＣＳ３００６、Ｅ６２０１、ＦＣＮ-１５９、Ｇ-３８９６３、ＧＤＣ-０６２３、ＨＬ-０８５、ＰＤ　９８０５９、ＲＯ４９８７６５５、ＲＯ５１２６７６６、ＳＨＲ　７３９０、ＴＡＫ-７３３、Ｕ０１２６、ＷＸ-５５４、またはその薬学的に許容される塩である、　（ｅ）ＭＥＫを標的とする前記薬剤が、０．１ｍｇ～５ｍｇの間の用量で投与される、　（ｆ）ＭＥＫを標的とする前記薬剤が、トラメチニブである、および／または　（ｇ）ＭＥＫを標的とする前記薬剤が、コビメチニブである、請求項１から４または６から１８のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７、９から１５、または１８のいずれか一項に記載の医薬組成物。

20a：前記がん免疫療法が、ＰＤ-１またはＰＤ-Ｌ１結合アンタゴニストを含む、請求項１から４または６から１９のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７、９から１５、１８または１９のいずれか一項に記載の医薬組成物。

21a：（ａ）前記がん免疫療法が、抗ＰＤ-１抗体分子を含み、前記抗ＰＤ-１抗体分子が、（ｉ）配列番号５０１のＶＨＣＤＲ１アミノ酸配列、配列番号５０２のＶＨＣＤＲ２アミノ酸配列、および配列番号５０３のＶＨＣＤＲ３アミノ酸配列を含む重鎖可変領域（ＶＨ）；ならびに配列番号５１０のＶＬＣＤＲ１アミノ酸配列、配列番号５１１のＶＬＣＤＲ２アミノ酸配列、および配列番号５１２のＶＬＣＤＲ３アミノ酸配列を含む軽鎖可変領域（ＶＬ）、　（ｉｉ）配列番号５０６のアミノ酸配列、あるいは配列番号５０６に対して少なくとも８５％、９０％、９５％、もしくは９９％同一であるかまたはそれより高い割合で同一であるアミノ酸配列を含むＶＨ、または配列番号５２０のアミノ酸配列、あるいは配列番号５２０に対して少なくとも８５％、９０％、９５％、もしくは９９％同一であるかまたはそれより高い割合で同一であるアミノ酸配列を含むＶＬ、　（ｉｉｉ）配列番号５０６のアミノ酸配列、あるいは配列

番号５０６に対して少なくとも８５％、９０％、９５％、もしくは９９％同一であるかまたはそれより高い割合で同一であるアミノ酸配列を含むＶＨ、および配列番号５１６のアミノ酸配列、あるいは配列番号５１６に対して少なくとも８５％、９０％、９５％、もしくは９９％同一であるかまたはそれより高い割合で同一であるアミノ酸配列を含むＶＬ、　（ｉｖ）配列番号５０８のアミノ酸配列、あるいは配列番号５０８に対して少なくとも８５％、９０％、９５％、もしくは９９％同一であるかまたはそれより高い割合で同一であるアミノ酸配列を含む重鎖、および配列番号５２２のアミノ酸配列、あるいは配列番号５２２に対して少なくとも８５％、９０％、９５％、もしくは９９％同一であるかまたはそれより高い割合で同一であるアミノ酸配列を含む軽鎖、または　（ｖ）配列番号５０８のアミノ酸配列、あるいは配列番号５０８に対して少なくとも８５％、９０％、９５％、もしくは９９％同一であるかまたはそれより高い割合で同一であるアミノ酸配列を含む重鎖、および配列番号５１８のアミノ酸配列、あるいは配列番号５１８に対して少なくとも８５％、９０％、９５％、もしくは９９％同一であるかまたはそれより高い割合で同一であるアミノ酸配列を含む軽鎖を含み、　（ｂ）前記がん免疫療法が、抗ＰＤ-１抗体分子を含み、前記抗ＰＤ-１抗体分子が、約３００ｍｇ～４００ｍｇの用量で、３週間に１回または４週間に１回前記対象に投与される、および／または　（ｃ）前記がん免疫療法が、第２のがん免疫治療剤を含む、請求項１から４または６から２０のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７、９から１５、または１８から２０のいずれか一項に記載の医薬組成物。

22a：前記がんが、　（ａ）固形腫瘍、血液がん、またはその転移巣である、　（ｂ）前記がんが、黒色腫またはその転移巣である、　（ｃ）前記がんが、黒色腫であり、前記黒色腫が、ステージＩの黒色腫、ステージＩＩの黒色腫、ステージＩＩＩの黒色腫、またはステージＩＶの黒色腫である、　（ｄ）前記がんが、黒色腫以外のがんである、　（ｅ）前記がんが、肺がん（例えば、非小細胞肺がん）、膵臓がん、もしくは結腸直腸がん、またはその転移巣である、（ｆ）前記がんが、ＢＲＡＦを標的とする薬剤および／またはＭＥＫを標的とする薬剤に対して難治性である、　（ｇ）前記がんが、ＢＲＡＦ変異を含む、請求項１から４または６から２１のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７、９から１５、または１８から２１のいずれか一項に記載の医薬組成物。

23a：さらなる治療の投与のために前記対象がさらに選択される、請求項１から４、または６から２２のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７、９から１５、または１８から２２のいずれか一項に記載の医薬組成物。

24a：（ａ）前記治療が、ファーストライン、セカンドライン、サードライン、もしくはフォースラインまたはそれを超える処置である、　（ｂ）前記治療が、アジュバント処置である、または　（ｃ）前記治療が、ネオアジュバント処置である、　請求項２３に記載の方法、または医薬組成物。

25a：前記方法が、ＴＩＬ、ＰＤ-Ｌ１、ＣＤ８、ＩＦＮγ、またはＴ細胞炎症遺伝子発現シグネチャーを含む免疫活性化のレベルおよび／または活性の値を取得するステップをさらに含む、請求項１から４または６から２４のいずれか一項に記載の方法、または請求項５から７、９から１５、または１８から２４のいずれか一項に記載の医薬組成物。

【請求項26】

26a：がんを有する対象を第１の群と第２の群に層別化する方法であって、　前記対象からの試料中のＣＤ８＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性に対するＣＤ４＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性の値を取得するステップと、　参照値よりも小さい値を有する対象を、がん免疫療法を用いない標的治療を含む治療からの利益を得る可能性が高い前記第１の群に割り当てるステップと、　参照値よりも大きいかまたはそれに等しい値を有する対象を、がん免疫療法と組み合わせて標的治療を含む治療からの利益を得る可能性が高い前記第２の群に割り当てるステップとを含む方法。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年 3月18日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-26	2G045	G01N33/574*(スパルタリズマブ+ダブラフェニブ+トラメチニブ)/TX	174
2	1-26	2G045	G01N33/53*(スパルタリズマブ+ダブラフェニブ+トラメチニブ)/TX-\01	166
3	1-26	外国	G01N2800/52/CP*(spartalizumab+dabrafenib+trametinib)/TX	297
4	1-26	外国	G01N33/574/CP*(spartalizumab+dabrafenib+trametinib)/TX-\03	244
5	1-26	外国	G01N33/53/CP*(spartalizumab+dabrafenib+trametinib)/TX-\03-\04	45
6	1-26	中韓	G01N33/574/IP*(スパルタリズマブ+ダブラフェニブ+トラメチニブ)/TX	99
7	1-26	中韓	G01N33/53/IP*(スパルタリズマブ+ダブラフェニブ+トラメチニブ)/TX-\06	17
8	1-26	中韓	([治療+処置+療法]*応答)/TX*(スパルタリズマブ+ダブラフェニブ+トラメチニブ)/TX*バイオマーカ/TX-\06-\07	423
9	1-26	外国	G/CP*(therapy+treatment+regimen),5N,response/TX*(spartalizumab+dabrafenib+trametinib)/TX*biomarker/TX-\03-\04-\05	175
10	1-26	外国	C/CP*(therapy+treatment+regimen),5N,response/TX*(spartalizumab+dabrafenib+trametinib)/TX*biomarker/TX-\03-\04-\05-\09	575
11	1-26	外国	C/CP*(therapy+treatment+regimen),5N,response/TX*(spartalizumab+dabrafenib+trametinib)/TX*biomarker/TX-\03-\04-\05-\09-\10	405
12	1-26	外国	(therapy+treatment+regimen),5N,response/TX*(spartalizumab+dabrafenib+trametinib)/TX*biomarker/TX-\03-\04-\05-\09-\10-\11	223
13	1-26	なし	([治療+処置+療法]*応答)/TX*(スパルタリズマブ+ダブラフェニブ+トラメチニブ)/TX*バイオマーカ/TX-\01-\02	664
14	1-26	なし	([治療+処置+療法]*応答)/TX*(スパルタリズマブ+ダブラフェニブ+トラメチニブ)/TX*バイオマーカ/TX-\01-\02-\13	426
15	1-26	外国	(G01N33/574*G01N2800/52)/CP*(CD4+CD8),5N,ratio/TX	115
16	1-26	STN	別添（備考）を参照	1

スクリーニング件数合計：4049

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		米国特許出願公開第２０２０／０３７１０９１号明細書	Y2	STN
2	特許文献		米国特許出願公開第２０１１／００９１４８１号明細書	Y2	3
3	特許文献		特表２０１７-５３６８４２号公報	Y3	1
4	特許文献		国際公開第２０２１／０２５０３１号	Y3	6
5	非特許文献		Murta EFC, de Andrade JM, Falcio RP, Bighetti S., Lymphocyte Subpopulations in Patients with Advanced Breast Cancer Submitted to Neoadjuvant Chemotherapy., Tumori Journal., ２０００年　９月, 86(5):, 403-407., doi:10.1177/030089160008600507,	Y2	ISRX
6	非特許文献		Shah, W., Yan, X., Jing, L. et al., A reversed CD4/CD8 ratio of tumor-infiltrating lymphocytes and a high percentage of CD4+FOXP3+ regulatory T cells are significantly associated with clinical outcome in squamous cell carcinoma of the cervix., Cell Mol Immunol, ２０１０年１１月２２日, 8,, 59-66, https://doi.org/10.1038/cmi.2010.56,	Y2	ISRX
7	非特許文献		Alfred L. Garfall, Ehren K. Dancy, Adam D. Cohen, Wei-Ting Hwang, Joseph A. Fraietta, Megan M. Davis, Bruce L. Levine, Don L. Siegel, Edward A. Stadtmauer, Dan T. Vogl, Adam Waxman, Aaron P. Rapoport, Michael C. Milone, Carl H. June, J. Joseph Melenhorst;, T-cell phenotypes associated with effective CAR T-cell therapy in postinduction vs relapsed multiple myeloma., Blood Adv, ２０１９年１０月　１日, 3 (19):, 2812-2815., doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2019000600,	Y2	ISRX
8	非特許文献		Zuazo Miren , Arasanz Hugo , Bocanegra Ana , Fernandez Gonzalo , Chocarro Luisa , Vera Ruth , Kochan Grazyna , Escors David, Systemic CD4 Immunity as a Key Contributor to PD-L1/PD-1 Blockade Immunotherapy Efficacy, Frontiers in Immunology, ２０２０年１１月３０日, Volume 11 - 2020, Pages 1-10, https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2020.586907,	Y3	ISRX
9	非特許文献		Charlotte E. Ariyan, Mary Sue Brady, Robert H. Siegelbaum, et al, Robust Antitumor Responses Result from Local Chemotherapy and CTLA-4 Blockade., Cancer Immunol Res, ２０１８年　２月　１日, 6 (2):, 189-200., https://doi.org/10.1158/2326-6066.CIR-17-0356,	Y2	別

10	非特許文献		Chad Tang, James W. Welsh, Patricia de Groot, et al, Ipilimumab with Stereotactic Ablative Radiation Therapy: Phase I Results and Immunologic Correlates from Peripheral T Cells., Clin Cancer Res, ２０１７年　３月１４日, 23 (6):, 1388-1396., https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-16-1432,	Y2	別
11	非特許文献		Dummer, R., Lebbe, C., Atkinson, V. et al., Combined PD-1, BRAF and MEK inhibition in advanced BRAF-mutant melanoma: safety run-in and biomarker cohorts of COMBI-i., Nat Med, ２０２０年１０月　５日, 26,, 1557-1563, https://doi.org/10.1038/s41591-020-1082-2,	Y1	別

【提示文献数】： 11

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームＮｏ．】	【文献Ｎｏ．】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1-26	本願			1a 1b 1c 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a 19a 20a 21a 22a 23a 24a 25a 26a 1a：癌治療に対する応答の特定方法(F6-1,2)1b：ＣＤ８＋／ＣＤ４＋を取得(F6-1,2)1c：癌免疫療法と標的療法との組み合わせのとき、大きいＣＤ８＋／ＣＤ４＋が高利益、または、標的療法のみのとき、小さいＣＤ８＋／ＣＤ４＋が高利益(F6-1,2)2a：癌免疫療法と標的療法との組み合わせのとき、小さいＣＤ８＋／ＣＤ４＋が低利益(F6-1,2)3a：請求項２の治療選択方法4a：治療のために対象を選択(F6-1,2)5a：請求項１の医薬組成物6a：ＣＤ８＋／ＣＤ４＋が細胞量比(F6-1,2)7a：ＣＤ８＋／ＣＤ４＋が２など(F6-3)8a：ＣＤ８＋／ＣＤ４＋が細胞レベルを決定(F6-1,2)9a：試料が血液など(F6-1,2)10a：ＣＤ８＋／ＣＤ４＋が細胞治療１か月後などに取得(F6-1,2)11a：ＴＩＬの増加が高利益(F15-6)12a：ＴＭＢの増加が高利益(F7-1)13a：ＴＭＢが１０ｍｕｔ／Ｍｂ以下(F7-1)14a：ＰＤ-Ｌ１の減少が高利益(F7-1)15a：ｃｔＤＮＡの増加が高利益(F19-3-6)16a：対象のＰＦＳなどが改善(F6-1,2)17a：ＰＦＳなどが１か月など改善(F6-1,2)18a：対象が治療されている(F6-1,2)19a：標的治療がダブラフェニブとトラメチニブ(F6-1,2)20a：癌免疫療法がＰＤ-１アンタゴニスト(F6-1,2)21a：癌免疫療法が抗ＰＤ-１抗体(F6-1,2)22a：癌が黒色腫など(F6-1,2)23a：さらなる治療(F6-1,2)24a：治療がファーストラインなど(F6-1,2)25a：ＴＩＬなどを取得(F6-1,2)26a：請求項３の対象層別化方法
1-26	1	Y2	F1B,N1007,N1179	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1b,3a,5a,6a,7a,8a,20a,21a,26a:多発性骨髄腫患者のＣＡＲＴ-ＢＣＭＡ治療において、高レベルのＣＤ４／ＣＤ８患者が高い応答性、抗ＰＤ-１抗体、スパルタリズマブ
1-26	2	Y2	C1,C3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1b,3a,5a,6a,7a,8a,26a:自己免疫疾患患者に対する免疫抑制剤治療において、低レベルのＣＤ４＋／ＣＤ８＋が高い応答性

1-26	3	Y3	N370	○ 19a:ＯＸ４０アゴニストと併せて投与されるダブラフェニブとトラメチニブ
1-26	4	Y3	N76,N254	○ ○ ○ 19a,20a,21a:Ｂ-ＲＡＦ阻害剤、ダブラフェニブ、ＭＥＫ阻害剤、トラメチニブ、抗ＰＤ-１抗体、スパルタリズマブ
1-26	5	Y2	Abstract,T5	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1b,3a,5a,6a,7a,8a,26a:乳癌患者に対する術前化学療法において、完全または部分応答患者のＣＤ４／ＣＤ８が非応答患者より高い
1-26	6	Y2	Abstract,F6	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1b,3a,5a,6a,7a,8a,26a:子宮頸癌患者において、高レベルのＣＤ４／ＣＤ８患者の５年生存率が低レベル患者より有意に高い
1-26	7	Y2	P2813(Par3),F1B	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1b,3a,5a,6a,7a,8a,26a:多発性骨髄腫患者において、誘導後患者のＣＤ４／ＣＤ８レベルがＣＡＲＴ-ＢＣＭＡ治療の応答患者より有意に高い
1-26	8	Y3	P5(Par3)	△ △ △ △ △ 1b,11a,12a,13a,14a:ＰＤ-Ｌ１／ＰＤ-１妨害治療に対する応答バイオマーカーがＣＤ４、ＰＤ-Ｌ１、ＴＭＢ、ＴＩＬ
1-26	9	Y2	Abstract,F4D	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1b,3a,5a,6a,7a,8a,26a:メラノーマ患者に対するメルファラン、イピリムマブ治療において、治療後のＣＤ８＋／ＣＤ４＋ＦＯＸＰ３＋が治療前に比べて有意に増加
1-26	10	Y2	P1389(Par2),F3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1b,3a,5a,6a,7a,8a,26a:癌患者に対するイピリムマブ／ＳＡＢＲ治療において、イピリムマブ治療後の応答患者のＣＤ８＋／ＣＤ４＋が非応答患者に対して有意に増加
1-26	11	Y1	Abstract,F1,F2,Ex.Data.F6,Supple.T5	○ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 1a,1b,1c,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a,23a,24a,25a,26a:ＢＲＡＦ変異メラノーマ患者に対するＳｐａｒｔａ-ＤａｂＴｒａｍ治療のバイオマーカー解析において、高レベルのＴＭＢ、ＧＥＳ、低レベルのｃｔＤＮＡ患者のＰＦＳが高く、治療後のＨスコア（ＴＩＬ）、ＩＦＮ-γが増加してＰＤ-Ｌ１が減少；ＣＤ４／ＣＤ８、高レベルのｃｔＤＮＡではない

		1a	1b	1c	2a	3a	4a
D1	Y2		○			○	
D2	Y2		○			○	
D3	Y3						
D4	Y3						
D5	Y2		○			○	
D6	Y2		○			○	
D7	Y2		○			○	
D8	Y3		△				
D9	Y2		○			○	
D10	Y2		○			○	
D11	Y1	○	△	○	○	△	○

5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a	24a	25a	26a
○	○	○	○												○	○					○
○	○	○	○																		○
														○							
														○	○	○					
○	○	○	○																		○
○	○	○	○																		○
○	○	○	○																		○
						△	△	△	△												
○	○	○	○																		○
○	○	○	○																		○
△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△

5．備考（検索者用）

2025年度版_Ver1.1

2025 年 10 月 27 日

検　索　報　告　書 （区分3，4，5，25）（STN検索履歴）

登録調査機関 工業所有権協力センター　区分 03　外国特許文献検索 0：外国検索＋中韓特許文献検索

指導者　コード KC3A　検索者　コード KD55

テーマコード 2G045　出願番号 特願2023-557063　種別 U：外国（オンライン対話）

外注管理番号 2025098507　事前相談 0:非事前相談型_事前対話なし　対話実施日　年　月　日

CSDB,学術 0：オプションなし　JPO配列　STN ○　その他 0：オプションなし　JDreamIII

STN検索履歴

STNアクセス回数（検索実施日）	DB ファイル名	回答セット L番号	検索式・検索履歴	ヒット化合物数	化合物表示数	ヒット文献レコード数	文献レコード表示数	手順等説明
2025/11/11	REGISTRY	L1	(TYWMH(L)NIYPGTGGSNFDEKFKN)/SQSP			97		
		L2	NIYPGTGGSNFDEKFKN(L)WTTGTGAY)/SQS			97		
		L3	KSSQSLLDSGNQKNFLT(L)WASTRES)/SQS			164		
		L4	(WASTRES(L)QNDYSYPYT)/SQSP			414		
	CAPLUS	L5	L1			964		
		L6	L2			964		
		L7	L3			966		
		L8	L4			1137		
		L9	L5 AND L6 AND L7 AND L8			964		
		L10	L9 AND NOVARTIS/PA			62		
		L11	L10 AND WO2019108900/PN			1	1	